

**AX03-POE-Seguimiento INR-001-V3: RECOMENDACIONES PARA EL PACIENTE
ANTICOAGULADO**

Vivir anticoagulado:

El tratamiento anticoagulante oral es un tratamiento crónico (muchas veces de por vida) y que requiere:

- Conocer bien el fármaco y sus posibles complicaciones
- Entender y responsabilizarse de su control
- Adecuar los hábitos para que afecte lo menos posible a la calidad de vida.

Importancia de la anticoagulación:

En la actualidad, han aumentado de forma muy importante las indicaciones del tratamiento anticoagulante.

Las razones principales son el aumento de la edad de los pacientes, la mayor seguridad en el control de ese tratamiento y el gran beneficio que aporta evitando trombosis y embolias.

En España (año 2010) se estima que cerca de 1 millón de pacientes toman anticoagulantes orales.

Cada año ese número aumenta entre un 10-15 %.

Tratamiento:

En España, el anticoagulante oral más habitual es el **SINTROM®** (Acenocumarol).

Objetivo del tratamiento:

- El objetivo **FUNDAMENTAL** es conseguir un nivel de anticoagulación óptimo, de acuerdo a su condición particular.
- Tomando las dosis diariamente y ajustando las dosis en los controles periódicos, intentaremos estar siempre dentro de los **límites terapéuticos y seguros**.
- **Por debajo** de esos límites: aumenta su riesgo de **trombosis o embolia**.
- **Por encima** de esos límites: aumenta su **riesgo de hemorragias**.

Disponemos de:

- **SINTROM UNO®** (grageas de 1 mg)
- **SINTROM®** (comprimidos ranurados de 4 mg)
 - Otra posibilidad es tomar ALDOCUMAR® (Warfarina):
 - Son comprimidos de 1 mg (rosa), 3 mg (azul), 5 mg (amarillo) o 10 mg (rojo)

Importancia de realizar los controles de INR

Existe un margen estrecho entre los niveles de INR adecuados (terapéuticos) y aquellos que pueden provocar complicaciones:

- Los valores demasiado bajos de INR favorecen la posibilidad de trombosis o embolia.
- Los niveles demasiado altos favorecen las hemorragias.

Dosis que debe tomar:

- La dosis que deberá tomar diariamente estará determinada por los controles periódicos que realiza. En su pauta recomendada cada día tendrá asignada una cantidad de anticoagulante.
- La dosis es personal e individual para cada paciente. No se compare con otros pacientes.
- En cada caso, será la dosis adecuada para conseguir el nivel de anticoagulación idóneo.

La cantidad de anticoagulante no tiene nada que ver con estar más o menos enfermo.

¿Por qué a veces me hacen descansar?

- El nivel de anticoagulación (INR) puede estar:
- **Demasiado ALTO:** Le harán descansar durante uno o dos días o incluso le darán un suplemento de vitamina K *para corregir la desviación y le harán un nuevo control.*
- **Demasiado BAJO:** existirá riesgo de trombosis o embolia. Se administrarán inyecciones subcutáneas de heparina durante unos días para protegerle hasta que haga efecto el aumento de las dosis.

Dosis y fechas de los controles:

- Después de cada control su médico o enfermera, le entregará un calendario con las dosis que debe tomar cada día y la nueva fecha de control.
- Cada día deberá ir comprobando en ese calendario la dosis que debe tomar y después de hacerlo deberá tacharla con el fin de estar seguro de que tomó la medicación.

¿Cuándo tomar el anticoagulante oral?

- Acostumbrarse a tomarlo todos los días más o menos a la misma hora.
- Se aconseja tomarlo por la tarde, antes de cenar y no interferir con los horarios de comidas.
- No tomarlo a primera hora de la mañana porque eso impide corregir la dosis el mismo día, si el control INR sale mal.

¿Qué debe hacer si se olvida alguna toma?

- Si se olvida de la toma a la hora habitual se acuerda durante el día, se la puede tomar.
- Si olvida una toma y no se acuerda hasta el día siguiente, tome la dosis que corresponda al día en que está.

NO TOME EL DOBLE para compensar.

Frecuencia de los controles:

- **El CONTROL** periódico de su tratamiento anticoagulante es fundamental para disminuir al máximo las posibles complicaciones.
- La frecuencia de los controles es variable:

Al principio de su tratamiento los controles serán más frecuentes.

Una vez su tratamiento sea estable, los controles serán entre 4-6 semanas.

FUNDAMENTAL: NO DEJAR DE HACER ESTOS CONTROLES EN LA FECHA INDICADA.

ALIMENTACION:

- Puede comer de todo, de forma variada y equilibrada.
- Si quiere **INICIAR** una dieta adelgazante o vegetariana, consulte a su médico y/o enfermera.
- La mayor parte de la vitamina K procede de los alimentos de origen vegetal, especialmente hortalizas de color amarillo oscuro o verduras de hoja verde como las espinacas, el brócoli, el repollo, la lechuga romana, las endibias, la col rizada, la remolacha, los espárragos y algunas clases de soja fermentada. Estos alimentos no están prohibidos pero deben ser controlados en la dieta.
- Se recomienda tomar dos raciones de verduras y hortalizas diarias (preferentemente una de ellas crudas.)
- Los **alimentos de origen animal** no suelen contener cantidades apreciables de vitamina K (salvo el hígado) y pueden ser tomados sin preocupación. Algunos alimentos muy grasos pueden contener formas de vitamina K y no son buenos para su salud cardiovascular (aumentan el colesterol malo); por ello, **disminuya el consumo de grasas animales** (como mantequilla, tocino, bollería industrial, carnes grasas, embutidos, quesos, bacon, nata) y elija más pescado que carne.

TABACO:

- El tabaco es muy rico en Vitamina K, por lo cual puede frenar el efecto del anticoagulante.
- El tabaco es un importante factor de riesgo de enfermedad cardiovascular y provoca cáncer y graves enfermedades respiratorias.

ALCOHOL:

- Puede tomar una cantidad moderada de vino o cerveza en las comidas, y mejor con regularidad que esporádicamente.
- También puede brindar con cava o champagne en una celebración.
- No abuse, puesto que el alcohol interacciona con el tratamiento anticoagulante y puede hacer muy difícil su control.
- Beber de forma crónica disminuye el efecto anticoagulante del acenocumarol y beber de forma aguda hace que aumente el efecto anticoagulante.

VIAJES:

- Procure tener un control reciente antes de iniciar su viaje.
- Lleve consigo su calendario de dosificación y medicación suficiente para todos los días del viaje.
- Averigüe si en el lugar donde va existen centros donde puedan hacerle un control si lo necesita.

MEDICACIÓN:

- Advertir siempre que toma anticoagulantes.
- Mantener el medicamento en un lugar fresco, sin humedad, lejos de fuentes de calor y luz directa.
- No dejar al alcance de los niños.
- Cuidado con la automedicación y productos de herboristería

HIGIENE:

- Mantenga una adecuada higiene personal con ducha diaria y revise su piel en busca de hematomas.
- Hidrate su piel a diario con el fin de que sea flexible y no se rompa fácilmente.
- Utilice para la higiene dental un cepillo de cerdas suaves y cabeza pequeña (los más adecuados son los infantiles).
- Si tiene que rasurarse no utilice cuchillas, use maquinilla eléctrica.

ESTREÑIMIENTO:

- Los anticoagulantes se toman por vía oral y se absorben en el aparato digestivo.
- La persona que toma anticoagulantes debe evitar el estreñimiento en lo posible. Para ello:
 - Beba abundante líquido.
 - Tome alimentos ricos en fibra (fruta, verdura, pan integral...).
 - Haga ejercicio físico regularmente.
 - Eduque el hábito. Aproveche el reflejo que aparece después de comer.
 - Si hace falta, puede tomar laxantes suaves: Lactulosa o supositorios de glicerina.

DENTISTA:

- Informe siempre de que está en tratamiento con anticoagulantes cuando le den cita.
- No es necesario suspender su tratamiento anticoagulante, pero puede que haya que tomar algunas medidas.
- Si tiene una extracción dentaria, hágase un control el día previo para conocer el nivel de anticoagulación (INR).
- Una limpieza bucal puede provocar sangrado.
- Normalmente, después de la extracción dental, su dentista le dará un tratamiento local hemostático (aplicación y enjuagues) con Amchafibrin®, Espongostan®, Caprofides®.
- Si la manipulación es más importante (implantes, prótesis dentales exodoncias múltiples, etc.), siga las indicaciones que le dé el odontólogo.
- Recuerde siempre que debería realizar profilaxis antibiótica, sobre todo si tiene una prótesis valvular.

INYECCIONES:

- Puede ponerse las vacunas habituales (gripe, catarro, antitetánica...) de forma subcutánea (bajo la piel).
- Evite las inyecciones intramusculares pues pueden producir hemorragias o hematomas importantes.
- Valore siempre otras alternativas (tratamientos orales, intravenosos, etc).

PRUEBAS O INTERVENCIONES:

- Por su tratamiento anticoagulante siempre tendrá una mayor posibilidad de sangrado.
- Ante cualquier prueba diagnóstica invasiva o que implique realizar cortes o biopsias, debe alertar al médico: endoscopias (tubos en aparato respiratorio urinario o digestivo), electromiografías, toma de muestras o biopsias, etc.
- Ante cualquier intervención quirúrgica, por pequeña que sea, debe avisar con antelación a los médicos y anestesistas para que le preparen adecuadamente.

MEDICINA NATURISTA:

- Algunos preparados de herboristería interfieren de forma importante con la medicación anticoagulante. Evite las infusiones de té verde.
- Evite los suplementos vitamínicos ricos en Vitamina K.
- Compruebe la composición y los efectos de los preparados homeopáticos, puesto que podrían interferir con su tratamiento.
- ANTE LA DUDA, CONSULTE CON SU CENTRO DONDE LE REALIZAN EL CONTROL

VIDA SEXUAL:

- Las personas en tratamiento anticoagulante pueden realizar una vida sexual normal.
- Obviamente, se desaconsejan las prácticas sexuales violentas o agresivas, por el mayor riesgo de sangrado.
- Se recomiendan las mismas prevenciones que para cualquier otra persona para evitar las enfermedades de transmisión sexual.

ANTICONCEPTIVOS:

- Se recomiendan los métodos de barrera, como preservativos, diafragmas y espermicidas.
- Los Dispositivos intrauterinos (DIU) no están contraindicados, pero en algunos casos pueden provocar hemorragias.
- Las píldoras anticonceptivas deben evitarse en lo posible. La mayoría de ellas llevan estrógenos que pueden incrementar el riesgo de trombosis. Si se toman, hay que dosificar muy bien el anticoagulante y hacer más controles.
- Naturalmente, los métodos más seguros y definitivos son la ligadura de trompas y la vasectomía.

EMBARAZO:

- Toda mujer en edad fértil que tome anticoagulantes orales y tenga un retraso de la regla de una semana, debe comprobar que no esté embarazada.
- En el caso de que la prueba de embarazo sea positiva, debe consultar cuanto antes con el médico responsable del control de su TAO.
- El embarazo exige que en el primer trimestre y en el último mes se suspenda el TAO por la posibilidad de malformaciones fetales y hemorragias en el recién nacido.
- Además, en las mujeres portadoras de prótesis cardíacas, el embarazo tiene un riesgo altísimo de trombosis de la prótesis y de mortalidad para la madre, por lo que debería desaconsejarse.

LACTANCIA:

- No se han descrito trastornos en lactantes de madres que toman anticoagulantes.
- Los anticoagulantes orales más usados, Acenocumarol y Warfarina, no se excretan en la leche materna y por lo tanto, no afectan al lactante.
- Debe vigilar también las grietas del pezón por la posibilidad de sangrado.

ACTIVIDAD DEPORTIVA:

- El TAO es compatible con la actividad física o deportiva poco traumática, siempre que su estado de salud y su función cardíaca lo permitan.
- Son aconsejables la natación, la gimnasia, caminar, correr, aeróbic...
- No hay mayor inconveniente en tenis, ciclismo, voleibol, remo...
- Se recomienda extremar la precaución en deportes de contacto o de riesgo de caídas: fútbol, baloncesto, balonmano, esquí, patinaje...
- Están contraindicados los deportes violentos: rugby, kárate, lucha...

ALGUNAS PRECAUCIONES:

- Evite los masajes fuertes y profundos.
- Evite las manipulaciones articulares.
- Se desaconsejan los tatuajes y los piercings.
- Se recomienda precaución con la acupuntura.
- No olvide que su tratamiento anticoagulante le hace estar predispuesto a las hemorragias.